carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Introducción a la disfunción Física

semana 08

PATOLOGÍAS REUMÁTICAS

Presente.

Lic. Richard Rojas Galindo
DOCENTE

Analicemos el video y den sus opiniones a través de una lluvia de ideas

https://www.youtube.com/watch?v=IUef10P8zdk

DESCRIBE QUÉ OBSERVAS EN LA IMAGEN

1. …
2. …

https://artritistratamiento21dias.blogspot.com/2016/07/8-ejercicios-para-artritis-en-las-manos.html

¿CUÁLES PODRÍAN SER LOS POSIBLES DIAGNÓSTICOS

1. …
2. …

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

TEMARIO

PATOLOGÍAS REUMÁTICAS

1. **Artritis reumatoide:**
   - Concepto
   - Signos y síntomas
   - Causas
   - Clasificación
   - Diagnóstico.
1. **Gota** :
   - Concepto
   - Signos y síntomas
   - Causas
   - Diagnóstico
1. **Artrosis:**
   - Concepto
   - Signos y síntomas
   - Causas
   - Diagnóstico
1. **Lupus eritematoso sistémico:**
   - Concepto
   - Signos y síntomas
   - Causas
   - Diagnóstico

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica las causas, los signos, síntomas y el diagnóstico de las patologías reumáticas.

ARTRITIS REUMATOIDE

Conceptualización

- Enfermedad sistémica autoinmune, caracterizada por provocar inflamación crónica principalmente de las articulaciones, que produce destrucción progresiva con distintos grados de deformidad e incapacidad funcional.
- Es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmunitario, caracterizada inicialmente por la inflamación de la membrana sinovial o sinovitis, que se extiende hasta otras estructuras articulares como el hueso, el cartílago articular, ligamentos y tendones, causando a la larga su destrucción.

https://www.elcorreodelorinoco.com/artritis-reumatoide-enfermedad-comun/

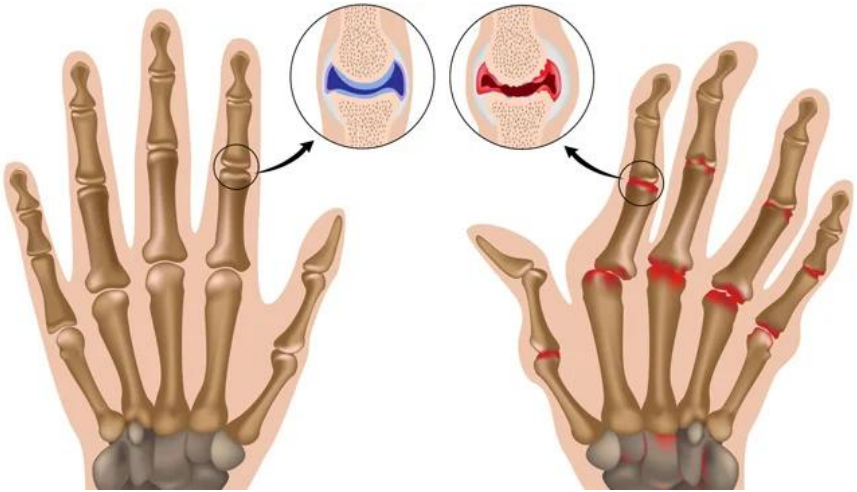
SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Dolor o hinchazón articular.
- La rigidez matutina, que dura por más de una hora, pueden sentirse calientes, sensibles y rígidas cuando no se usan durante una hora.
- Las articulaciones inflamadas con más frecuencia:
  - Muñecas
  - Nudillos
  - Articulaciones de los dedos de las manos y de los pies, codos, hombros caderas, rodillas, tobillos.
- La deformidad progresiva de las articulaciones y la pérdida reducción de la movilidad articular
- Discapacidad para hacer algunas tareas de la vida diaria.

https://www.respirodeporte.es/artritis-reumatoide-ar/

CAUSAS:

- Enfermedad autoinmunitaria.
- Factores desconocidos que inducen a la aparición de autoantígenos.
- Estos antígenos a los linfocitos T CD4 estimula la expresión de citocinas e induce y aumenta la proliferación de linfocitos B, con la consiguiente producción de anticuerpos.
- Los linfocitos B son los productores del factor reumatoide.
- Al comienzo de la enfermedad apenas un 60% de los pacientes son positivos para este marcador.
- No obstante, durante el primer año en algunos pacientes el factor reumatoide negativo se convierte en factor reumatoide positivo, de modo que este anticuerpo está presente en el 80% de los pacientes.



https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/diccionario-enfermedades/artritis-reumatoide

CAUSAS:

- Factores ambientales.
- Factores hormonales.
- Una de las posibilidades es la infección persistente de las estructuras articulares o la retención de los productos microbianos en los tejidos sinoviales, que genera una respuesta inflamatoria crónica.

https://www.lavanguardia.com/vida/salud/enfermedades-reumaticas/20190504/462023338510/artristis-artritis-reumatoide-articulaciones-dolor-fibromialgia-inflamacion-reumatologo-cartilago-condoprotectores.html

DIAGNÓSTICO

De acuerdo al Colegio Americano de Reumatología (ACR - American College of Rheumatology), se establece el diagnóstico de artritis reumatoide Siempre y cuando del criterio número uno al cuatro, estén presentes por al menos 6 semanas:

1. Rigidez matutina de al menos una hora de duración.
2. Artritis en 3 o más articulaciones.
3. Artritis de las articulaciones de la mano.
4. Artritis simétrica.
5. Nódulos reumatoideos.
6. Cambios radiológicos compatibles con AR.
7. Factor reumatoide positivo.

Dos pruebas de laboratorio que ayudan en el diagnóstico son:

- Prueba del factor reumatoideo
- Prueba de anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados (anticuerpos anti-PCC)

GOTA

https://blogs.ucv.es/podologia/los-casos-de-gota-han-aumentado-de-forma-espectacular-en-los-paises-occidentales-en-las-ultimas-decadas/

GOTA

CONCEPTUALIZACIÓN

Tipo de artritis que ocurre cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación articular (hiperuricemia) Gota aguda Afecta una articulación Gota crónica Episodios frecuentes de dolor. Implica más de 2 articulaciones.

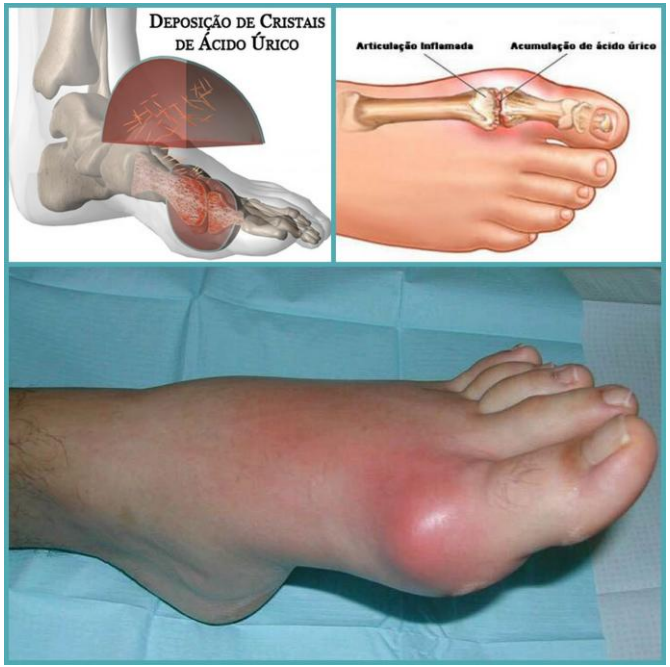
https://www.ramontormo.com/gota-tratamiento-con-dieta-dash-sal-y-ataques-de-gota/

SIGNOS Y SÍNTOMAS
(3 fases)

- Cualquier tipo de articulación (dedo de pie, tobillo y rodilla)
- Dolor insoportable.
- Intensidad durante los primeros días. Va desapareciendo poco a poco

GOTA AGUDA

- Ataque en una sola articulación.
- Periodo donde el paciente ha pasado de la anterior etapa donde actualmente no tiene síntomas.



http://nutrir-se-by-nutri.blogspot.com/2012/08/acido-urico-gota.html

CAUSAS:

- Acumulación de ácido úrico en el líquido sinovial, alrededor de las articulaciones.
- Personas con diabetes, enfermedades renales, obesidad, anemias y leucemias.
- Hipertensión arterial.
- Los riñones no eliminan suficiente ácido úrico.

CARACTERÍSTICAS:

- Inflamación
- Dolor
- Enrojecimiento
- Calor
- Edema
- Hipersensibilidad

https://www.cuidadodelasalud.com/preguntas-frecuentes/porque-la-enfermedad-de-la-gota-se-llama-asi/

Diagnóstico

Los médicos suelen diagnosticar gota según tus síntomas y la apariencia de la articulación afectada. Dentro de las pruebas que ayudan a diagnosticar gota se encuentran las siguientes:

- **Análisis del líquido sinovial.**
- **Análisis de sangre.**
- **Radiografías.**
- **Ecografía.**
- **Tomografía computarizada de doble energía.**

https://greennotes8.wixsite.com/notasmedicina/single-post/2015/11/28/Hiperuricemia-gota

ARTROSIS

- La osteoartritis o artrosis es la enfermedad degenerativa articular más frecuente, caracterizada por la destrucción del cartílago hialino que recubre las superficies óseas.
- El cartílago es un tejido que hace de amortiguador al proteger los extremos de los huesos y que favorece el movimiento de la articulación.
- Cuando se desarrolla la artrosis, dicho cartílago pierde sus propiedades.

https://fisiolution.com/artrosis-y-artritis-que-son/

SÍNTOMAS DE LA ARTROSIS

- Dolor.
- Deformidad.
- Inflamación y cúmulo de líquido sinovial.
- Atrofia de los músculos contiguos.

https://arribasalud.com/artrosis-degenerativa/

CAUSAS DE ARTROSIS

Aunque la causa última de la artrosis es desconocida, existen una serie de factores que se relacionan de manera directa con el deterioro progresivo de la articulación:

- **Edad**. El desgaste por el uso de las articulaciones aumenta a medida que se envejece.
- **Obesidad.** A mayor peso, mayor sobrecarga de estas estructuras y mayor desgaste.
- **Lesión o uso excesivo**. Los atletas y las personas con trabajos que requieren hacer movimientos repetitivos, tienen un mayor riesgo de desarrollar artrosis.
- **Genética.** Juega un papel en el desarrollo de la artrosis, especialmente en las manos, donde la sobrecarga mecánica no es tan evidente como en otras estructuras como las rodillas.
- **Actividad física**. Los estudios realizados de rodilla muestran que los ejercicios de fortalecimiento de los músculos del muslo (especialmente cuádriceps y musculatura isquiotibial) son importantes para reducir el riesgo de artrosis de rodilla.
- **Otras enfermedades**. Cualquier enfermedad que altere las articulaciones como la artritis, puede dañar el cartílago de manera precoz y producir una artrosis en la articulación de manera temprana.

https://theramart.com/blogs/de-salud/sintomas-tipos-artritis

FACTORES RELACIONADOS CON LA ARTROSIS

Sea o no conocida la causa última de la enfermedad, sí que podemos hablar de una serie de **factores estrechamente ligados a su desarrollo**:

1. **Factores sistémicos**: sexo, edad, herencia, osteoporosis (estado hormonal).
2. **Factores locales**: obesidad, inestabilidad articular (laxitud, deformidades), traumatismos repetidos, sobrecarga articular (ocupacional...).
3. **Factores genéticos**: existe una serie de genes estrechamente asociados al desarrollo de la artrosis que pueden estudiarse mediante un simple test de saliva.

DIAGNÓSTICO

- A la exploración física, pueden observarse **deformidades articulares**, por aumento del componente óseo y capsular y limitación de la movilidad con dolor a la presión, chasquidos y crepitación de la articulación.
- El crecimiento de los extremos de los huesos que forman la articulación puede hacer que la articulación se agrande y ensanche.
- La radiología en las fases iniciales puede ser normal, aunque lo más típico es observar un estrechamiento de espacio articular asociado a esclerosis subcondral, aparición de osteofitos marginales.

https://www.blogdefisioterapia.com/radiologia-de-la-artrosis-y-datos-de-laboratorio/

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

El **lupus** es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunitario del paciente ataca a diferentes órganos y tejidos (puede afectar a la piel, las articulaciones, los riñones, los pulmones, el sistema nervioso, etc.) provocando daño e inflamación.

https://www.haikudeck.com/lupus-eritematoso-sistemico-science-and-technology-presentation-UFxnIly5D6

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO: CONCEPTUALIZACIÓN

El lupus es una enfermedad que puede afectar a varios órganos:

1. **Piel:** La lesión más conocida, aunque no la más frecuente, es el “eritema en alas de mariposa”, que consiste en un enrojecimiento y erupción de la piel en las mejillas y nariz. Las lesiones de la piel en el lupus aparecen en cualquier parte del cuerpo y en general no dan molestias.
2. **Corazón y pulmones:** El lupus inflama las membranas de revestimiento del corazón (el pericardio) y de los pulmones (la pleura), lo que origina pericarditis y pleuritis. Ambos procesos tienen síntomas parecidos: dolor en el tórax y a veces fiebre.
3. **Riñón:** La lesión más frecuente es la inflamación (nefritis.) Aumenta la urea en sangre, y aparecen proteínas o sangre en la orina. La lesión del riñón es asintomática manifestándose en algunas ocasiones como cansancio o subida de la tensión arterial.
4. **Cerebro:** Es prácticamente imposible saber con qué frecuencia se afecta el cerebro en el lupus.
5. **Infecciones:** El paciente con lupus es sensible a las infecciones.
6. **El síndrome antifosfolípido:** Se caracteriza por la aparición de trombosis, abortos de repetición y alteraciones hematológicas (trombopenia o anemia hemolítica), asociados a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos (AAF.) Los AAF mejor conocidos son los anticuerpos anticardiolipina y el anticoagulante lúpico.

1. **Síntomas generales:** cansancio, pérdida de peso y fiebre prolongada, que no se debe a ningún proceso infeccioso.
2. **Síntomas articulares y musculares:** El 90% de los pacientes con lupus tienen dolor e inflamación de las articulaciones (artritis.) Las que más se afectan son las de los dedos de las manos, muñecas, codos, rodillas y las de los pies.

Es frecuente que el paciente note rigidez articular por las mañanas.

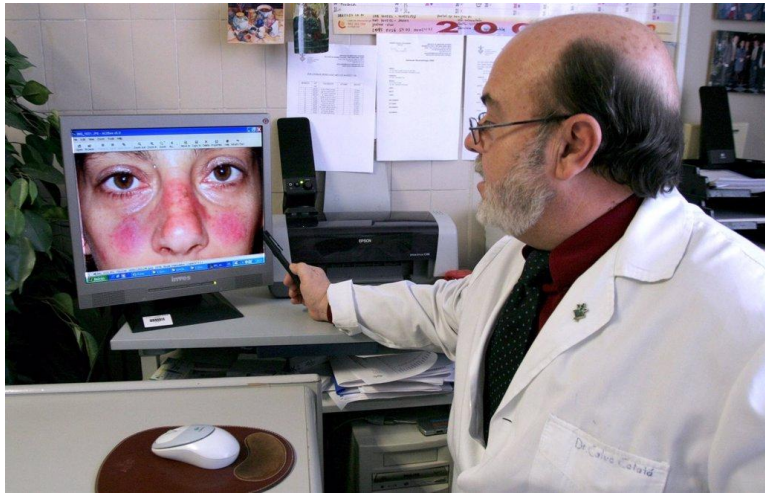
- Cansancio.
- Pérdida de peso.
- Dolor e inflamación de las articulaciones.
- Erupción en la piel de mejillas y nariz.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

https://www.genialconsalud.com/sintomas-del-lupus/

- El lupus eritematoso es difícil de diagnosticar.
- El diagnóstico se basa en los síntomas que cuenta el paciente, la exploración física y la analítica.
- En los análisis de sangre es frecuente que el número de leucocitos, linfocitos y plaquetas esté más bajo de lo normal.
- Prácticamente el 100% de los pacientes presenta anticuerpos antinucleares; cuando son negativos prácticamente se excluye la existencia de esta enfermedad.
- Hay otros anticuerpos más específicos del lupus, como los llamados anticuerpos anti-DNA o anti-Sm, cuya presencia permite confirmar el diagnóstico.
- La presencia de anticuerpos antifosfolípidos también ayuda a diagnosticar el lupus.

DIAGNÓSTICO



https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-diagnostico-precoz-clave-controlar-evolucion-lupus-20110509132054.html

ACTIVIDAD SINCRÓNICA

Elaboren un resumen de las patologías reumáticas mediante el análisis de archivos multimedia.

CONCLUSIONES

1. Las enfermedades reumáticas son aquellas que afectan el aparato locomotor principalmente a las articulaciones.
2. …
3. …

Metacognición

¿Qué aprendimos hoy?

¿Qué dificultades tuvimos?

¿Para qué nos sirve lo aprendido?

REFERENCIAS

Peña Ayala A, Fernández López JC. Prevalencia y factores de riesgo de la osteoartritis. Reumatol Clin. 2007;3 Supl 3:S6-12. Recuperado de:
https://unitia.secot.es/web/manual_residente/CAPITULO%2040.pdf

Murias Loza S, Alcobendas Rueda RM, Udaondo Gascón C. Artritis. Diagnóstico diferencial. Artritis. Diagnóstico diferencial. Unidad de Reumatología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid. Protoc diagn ter pediatr. 2020;2:17-26. Recuperado de:
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/02_artritis_diagn.pdf

García-Consuegra Molina J, Merino Muñoz R. Lupus eritematoso sistémico. Esclerosis sistémica y Dermatomiositis. Tratado de Reumatología. Editorial Arán. 1998. Recuperado de:
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/9-LES.pdf

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

¡Muchas gracias!

Presente.